

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E PROFILAXIAS



ROTINA CLÍNICA

Material bônus

CANDIDÍASE VAGINAL

Uso oral:

Fluconazol 150 mg

Tomar 1 comprimido por via oral em dose única.

Ou

Itraconazol 100 mg

Tomar 2 comprimidos de 12/12h por 1 dia.

Orientações gerais:

Evitar realizar ducha vaginal.

Evitar uso de roupas muito justas/apertadas.

Utilizar calcinha de algodão.

Realizar higiene íntima adequada.

Seguir acompanhamento ambulatorial.



ROTINA CLÍNICA

CANDIDÍASE VAGINAL

Uso tópico (vaginal):

Miconazol creme (2%)

Aplicar 5g (1 aplicador cheio) por via vaginal por 7 dias.

Orientações para uso (vide bula):

Adapte o aplicador ao bico da bisnaga.

Aperte a base da bisnaga com os dedos, de maneira a forçar a entrada do creme no aplicador, preenchendo todo o espaço vazio.

Retire o aplicador e feche novamente a bisnaga.

Introduza delicadamente o aplicador na vagina, o mais profundamente possível, e empurre o êmbolo para dentro, até esvaziar o aplicador.



ROTINA CLÍNICA

CANDIDÍASE VAGINAL

Uso tópico (vaginal):

Clotrimazol creme (1%)

Aplicar 5 g via vaginal por 7 a 14 dias.

Orientações para uso (vide bula):

O creme vaginal deve ser inserido na vagina o mais profundamente possível, à noite. Obtém-se inserção mais facilmente com a paciente deitada de costas, com as pernas levemente fletidas.



ROTINA CLÍNICA

SÍFILIS PRIMÁRIA

Uso intramuscular:

Penicilina G Benzatina injetável - 1.200.000 UI/4mL (frasco 4mL - suspensão injetável)

Existem apresentações prontas para uso, sem necessidade de reconstituição. Outras podem ser reconstituídas em 3,2 mL do diluente próprio (água para injeção). O volume final é de 4 mL. Administrar via IM profunda, 1 ampola em cada glúteo.

A dose total é de 2.400.000 UI (2 ampolas).

Detalhes:

Este esquema também pode ser usado para sífilis secundária e latente recente (< 1 ano de evolução). Sugerimos que investigue outras ISTs e oriente sobre métodos contraceptivos e de proteção contra ISTs.



ROTINA CLÍNICA

SÍFILIS PRIMÁRIA

Se alergia à penicilina ou indisponibilidade:

Uso oral:

Doxiciclina 100 mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 15 dias.

As referências utilizadas neste caso são recomendações do **Ministério da Saúde (MS)**.



ROTINA CLÍNICA

URETRITE

Detalhe:

Os agentes mais prevalentes são *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*.

Na maioria dos casos, não será possível identificar o agente e, por este motivo, utilizaremos esquema de tratamento efetivo contra ambos.

Uso oral:

Azitromicina 500 mg

Tomar 2 comprimidos em dose única.

+

Uso intramuscular:

Ceftriaxone 1g F/A

Reconstituir em 2,9 ou 3,5 mL de AD ou Lidocaína 1% sem vasoconstritor. Administrar 0,5 (meia) ampola via IM.



ROTINA CLÍNICA

URETRITE

Detalhe:

Podemos utilizar a Doxiciclina como substituta à Azitromicina (apesar de tal troca ser menos prática devido à sua posologia).

Uso oral:

Doxiciclina 100 mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

VAGINOSE BACTERIANA

Uso oral:

Metronidazol 250 mg

Tomar 2 comprimidos de 12/12h por 7 dias.

Ou

Uso tópico:

Metronidazol gel 100 mg/g

Aplicar 5g (1 aplicador) via intravaginal 1 vez ao dia por 10 dias.

Detalhe:

Não é necessário tratar mulheres assintomáticas (exceto gestantes).



ROTINA CLÍNICA

TRICOMONÍASE VAGINAL

Uso oral:

Metronidazol 250 mg

Tomar 2 comprimidos de 12/12h por 7 dias.

Detalhe:

Não utilizar Metronidazol creme neste caso!
As orientações gerais são similares às da candidíase vaginal.

Atenção:

Informe ao paciente que não é recomendado consumir álcool enquanto estiver em uso de Metronidazol devido ao risco de reação do tipo “Dissulfiram-like” ou “efeito Dissulfiram”.



ROTINA CLÍNICA

CANCRO MOLE (CANCROIDE)

Uso oral:

Azitromicina 500 mg

Tomar 2 comprimidos em dose única.

Ou

Ciprofloxacino 500 mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 3 dias.

Ou

Uso intramuscular:

Ceftriaxona 1g F/A

Reconstituir em 2,9 ou 3,5 mL de AD ou Lidocaína 1% sem vasoconstritor. Administrar 0,5 (meia) ampola via IM.



ROTINA CLÍNICA

LINFOGRANULOMA VENÉREO

Uso oral:

Doxiciclina 100 mg (primeira escolha)

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 21 dias.

Ou

Azitromicina 500 mg (2ª escolha/gestantes)

Tomar 2 comprimidos em tomada única uma vez por semana por 3 semanas.



ROTINA CLÍNICA

HERPES GENITAL

Primeira infecção (primo-infecção)

Aciclovir 400 mg

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 7 dias ou até a cicatrização completa das lesões.

(Pode-se utilizar 2 comprimidos de 200 mg neste caso).

Ou

Aciclovir 200 mg

Tomar 1 comprimido 5 vezes ao dia (sugestões de horários: 7h, 11h, 15h, 19h, 23h, 7h...) por 7 dias ou até a cicatrização completa das lesões.

Tais apresentações são disponíveis pelo SUS.



ROTINA CLÍNICA

HERPES GENITAL

Primeira infecção (primo-infecção)

Caso o paciente tenha possibilidade de comprar a medicação, recomendamos uso de Valaciclovir devido à sua posologia mais simplificada, o que facilita a adesão terapêutica.

Uso oral:

Valaciclovir 500 mg

Tomar 2 comprimidos de 12/12h por 7 dias ou até a cicatrização completa das lesões.



ROTINA CLÍNICA

HERPES GENITAL

Recorrência

Uso oral:

Aciclovir 400 mg

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 5 dias ou até a cicatrização completa das lesões.

(Pode-se utilizar 2 comprimidos de 200 mg neste caso).

Ou

Aciclovir 200 mg

Tomar 1 comprimido 5 vezes ao dia (sugestões de horários: 7h, 11h, 15h, 19h, 23h, 7h...) por 7 dias ou até a cicatrização completa das lesões.



ROTINA CLÍNICA

HERPES GENITAL

Recorrência

Novamente, caso o paciente tenha possibilidade de comprar a medicação, recomendamos uso de Valaciclovir devido à sua posologia mais simplificada, o que facilita a adesão terapêutica.

Uso oral:

Valaciclovir 500 mg

Tomar 2 comprimidos uma vez ao dia por 5 dias ou até a cicatrização completa das lesões.



ROTINA CLÍNICA

PROFILAXIAS

Anticoncepção de emergência

Uso oral:

Levonorgestrel 1,5 mg

Tomar 1 comprimido via oral em dose única, em até 5 dias após a relação sexual.

Ou

Levonorgestrel 0,75 mg

Tomar 2 comprimidos via oral em dose única, em até 5 dias após a relação sexual.



ROTINA CLÍNICA

PROFILAXIAS

Sífilis

Uso intramuscular:

Penicilina G Benzatina injetável - 1.200.000 UI/4mL (frasco 4 mL - suspensão injetável)

Existem apresentações prontas para uso, sem necessidade de reconstituição. Outras podem ser reconstituídas em 3,2 mL do diluente próprio (água para injeção). O volume final é de 4 mL. Administrar via IM profunda, 1 ampola em cada glúteo.

A dose total é de 2.400.000 UI (2 ampolas).

Clamídia

Uso oral:

Azitromicina 500 mg

Tomar 2 comprimidos em dose única.



ROTINA CLÍNICA

PROFILAXIAS

Gonorreia

Uso intramuscular:

Ceftriaxona 1 g F/A

Reconstituir em 2,9 ou 3,5 mL de AD ou Lidocaína 1% sem vasoconstritor. Administrar 0,5 (meia) ampola via IM.

Tricomoniase (não é consenso na literatura)

Uso oral:

Metronidazol 400 mg

Tomar 5 comprimidos em tomada única.



PROFILAXIAS

Hepatite B

Em caso de pessoas em situação de violência sexual não imunizadas ou com esquema vacinal incompleto para hepatite B, o MS recomenda **vacinação para HBV e imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHAHB).**

Se o paciente exposto for previamente vacinado e possuir anti-Hbs recente* ≥ 10 , não há necessidade de profilaxia.

Vacina:

A vacina para hepatite B deve ser aplicada no músculo deltoide ou na região do vasto lateral da coxa. O esquema do MS (para adultos) inclui 3 doses: 0, 1 mês e 6 meses.



PROFILAXIAS

Hepatite B

Imunoglobulina:

A IGHAHB deve ser administrada em dose única de 0,06 mL/kg, IM, em extremidade diferente da que recebeu a vacina para HBV, e se a dose da vacina ultrapassar 5 mL, deve-se dividir a aplicação em duas áreas corporais diferentes. A IGHAHB pode ser administrada até, no máximo, 14 dias após a violência sexual/exposição de risco, embora se recomende seu uso nas primeiras 48 horas a contar do ato, e está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).



PROFILAXIAS

HIV

Profilaxia pós-exposição (PEP): deve ser iniciada o mais precocemente possível, em até 72 horas após a exposição de risco.

Uso oral:

Tenofovir (TDF) 300 mg + Lamivudina (3 TC) 300 mg (comprimido conjugado)

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 28 dias.

+

Dolutegravir (DTG) 50 mg

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 28 dias.

Lembre-se: são **2 comprimidos** (1 conjugado com TDF + TC e 1 com DTG).



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Medicina de Emergência - FMUSP 17ª Edição.
- Materiais do Ministério da Saúde (MS).
- Whitebook®.
- Bula das respectivas medicações.

